

Trauma y TEPT

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es el trauma?

Un trauma es una experiencia que desborda la capacidad del sistema nervioso de procesarla e integrarla. No es el evento en sí mismo lo que define el trauma, sino el impacto que tiene sobre el organismo, el sistema de creencias y la capacidad de regulación.

Pueden ser traumáticas tanto experiencias únicas e intensas como situaciones crónicas y repetidas. Lo que determina el impacto es la combinación entre la naturaleza del evento, los recursos disponibles en ese momento y el contexto relacional.

Tipo de trauma	Descripción
Trauma simple (Tipo I)	Evento único, delimitado en el tiempo: accidente, desastre natural, asalto, pérdida traumática repentina.
Trauma complejo (Tipo II)	Exposición repetida o prolongada, frecuentemente en el contexto de relaciones cercanas: abuso, negligencia, violencia doméstica, cautiverio.
Trauma del desarrollo	Trauma complejo ocurrido durante la infancia o adolescencia, con impacto en el desarrollo de la identidad, el apego y la regulación emocional.
Trauma vicario	Impacto acumulativo en profesionales expuestos repetidamente al trauma de otros.

02. ¿Qué es el TEPT?

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es la respuesta clínica que puede desarrollarse tras la exposición a un evento traumático. Se caracteriza por la persistencia de síntomas que interfieren significativamente en el funcionamiento.

Cuatro grupos de síntomas:

- Reexperimentación: flashbacks, pesadillas, reacciones intensas ante recordatorios del trauma
- Evitación: de pensamientos, emociones, personas, lugares o situaciones relacionadas con el trauma
- Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo: creencias negativas sobre sí mismo o el mundo, culpa, distanciamiento emocional, anhedonia
- Hiperactivación: hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, irritabilidad, dificultades de sueño y concentración

03. Respuestas normales ante un evento traumático

Las respuestas que siguen a un trauma son respuestas normales del sistema nervioso ante una experiencia anormal. No indican debilidad ni patología en sí mismas:

- Entumecimiento emocional o shock inicial
- Recuerdos intrusivos o imágenes del evento
- Alteraciones del sueño y pesadillas
- Hipervigilancia y sobresalto
- Irritabilidad o explosiones emocionales
- Evitación de recordatorios
- Sensación de irrealidad o desconexión

Nota clínica: Estas respuestas son esperables en las semanas posteriores al evento. Se habla de TEPT cuando persisten más de un mes y generan deterioro significativo en el funcionamiento.

04. Impacto del trauma complejo

El trauma complejo, especialmente el ocurrido en la infancia, tiene un impacto más amplio que el TEPT clásico:

- Desregulación emocional severa: dificultad para modular la intensidad emocional
- Alteraciones de la identidad: sentido de sí mismo fragmentado o inestable
- Perturbaciones del apego: dificultad para confiar, vínculos marcados por miedo o dependencia
- Disociación: desconexión de pensamientos, emociones, sensaciones o identidad
- Somatización: síntomas físicos sin causa médica identificable
- Creencias profundamente negativas sobre uno mismo, los otros y el mundo

05. Mecanismos centrales

Mecanismo	Descripción clínica
Memoria traumática	Los recuerdos traumáticos no se almacenan como narrativa integrada sino como fragmentos sensoriales, emocionales y corporales que se reactivan ante estímulos asociados.
Evitación	Conductas de evitación de recordatorios mantienen el TEPT al impedir el procesamiento del material traumático.
Hipervigilancia	El sistema nervioso permanece en alerta como si la amenaza siguiera presente, generando agotamiento crónico.
Creencias traumáticas	El trauma genera creencias sobre la propia incapacidad ("soy débil"), culpa ("fue mi culpa") o el mundo ("nadie es confiable") que mantienen el malestar.

06. Abordaje clínico

Fases del tratamiento (modelo trifásico):

- Fase 1 — Estabilización y seguridad: construcción del vínculo terapéutico, regulación emocional, establecimiento de recursos internos y externos
- Fase 2 — Procesamiento del trauma: trabajo directo con el material traumático (EMDR, exposición prolongada, terapia narrativa)
- Fase 3 — Integración y reconexión: elaboración del impacto del trauma en la identidad y los vínculos, proyección hacia el futuro

Modalidades terapéuticas con evidencia:

- EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares)
- Terapia de exposición prolongada (TCC)
- Terapia cognitiva centrada en el trauma
- Terapias orientadas al cuerpo (especialmente en trauma complejo)
- DBT para el manejo de la desregulación emocional en trauma complejo